

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE INTOLERANCIA A LA INCERTIDUMBRE (IUS-12)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Transdiagnóstica de Vulnerabilidad Cognitiva y Sesgo ante la Ambigüedad

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Intolerancia a la Incertidumbre - Versión Abreviada (IUS-12).
Nombre Original (Inglés)	<i>Intolerance of Uncertainty Scale – Short Form (IUS-12)</i>
Autores Originales	Drs. R. Nicholas Carleton, M. A. P. J. Norton y Gordon J. G. Asmundson (2007).
Adaptación Española	González-Rodríguez et al. (2018); validación clínica y psicométrica de Flores-Kanter et al. (2020).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Cognitivo de Dugas / Carleton sobre la Intolerancia a la Incertidumbre.
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 12 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes (≥ 13 años) y adultos. Ámbito clínico ambulatorio, hospitalario y comunitario.
Tiempo de Administración	2 a 4 minutos en autoadministración; 5 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento psicométrico de acceso libre para investigación científica y práctica clínica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA INCERTIDUMBRE

La Intolerancia a la Incertidumbre (IU) se define como una predisposición disposicional caracterizada por la tendencia a interpretar situaciones inciertas, ambiguas o imprevistas como fuentes intolerables de amenaza, malestar o peligro subjetivo. Concebida originalmente en el modelo cognitivo del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) de Dugas y colaboradores, la IU constituye hoy un factor causal transdiagnóstico de primer orden implicado en el TOC, los trastornos alimentarios, el hipocondrismo y el trastorno depresivo recurrente.

A nivel neurobiológico, la intolerancia a la incertidumbre se asocia a una respuesta hiperreactiva y desproporcionada de la ínsula anterior bilateral y del complejo amigdalino frente a señales sensoriales imperfectas o resultados probabilísticos indeterminados. Dicha sobreactivación límbica coexiste con una conectividad funcional degradada con la corteza prefrontal ventromedial y el córtex cingulado anterior dorsal, lo cual impide la extinción normal de la alerta y empuja al sujeto a desplegar conductas compulsivas de neutralización, búsqueda incesante de reaseguro y parálisis decisional.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Factor de Incertidumbre	Ítems	Rango Dir.	Manifestación Cognitiva y Conductual Evaluada
1. Incertidumbre Prospectiva	1 al 7 (7 ítems)	7 a 35	Deseo activo de predictibilidad; rumiación orientada al porvenir, frustración por falta de datos y búsqueda de garantías.
2. Incertidumbre Inhibitoria	8 al 12 (5 ítems)	5 a 25	Parálisis cognitiva y conductual; bloqueo de la iniciativa, duda invalidante y sentimiento de vulnerabilidad ante la ambigüedad.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión de medida: alfa de Cronbach de 0.88 a 0.92 para la escala total; 0.85 para Incertidumbre Prospectiva y 0.84 para Incertidumbre Inhibitoria (González-Rodríguez et al., 2018).
Estructura Bifactorial	El AFC confirma el modelo bifactorial correlacionado (CFI = 0.97, TLI = 0.96, RMSEA = 0.051), superando netamente a la versión unifactorial y replicando la solución original de Carleton.
Validez Concurrente	Elevada correlación con preocupación patológica (PSWQ, $r = 0.66$), síntomas de ansiedad generalizada (GAD-7, $r = 0.61$), obsesiones y compulsiones (OCI-R, $r = 0.52$) e intolerancia al afecto negativo.
Sensibilidad al Cambio	Sensibilidad demostrada a la exposición a la incertidumbre y técnicas de resolución de problemas en TCC para TAG, con disminuciones post-intervención de $d > 0.75$.
Invarianza de Medida	Invarianza factorial estricta comprobada en muestras comunitarias y clínicas entre géneros y grupos de edad.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 12 reactivos se evalúa del 1 al 5 (1 = «Nada característico de mí», 2 = «Poco característico», 3 = «Algo característico», 4 = «Bastante característico», 5 = «Totalmente característico»).

- **Subescala Incertidumbre Prospectiva (IP):** Suma de los ítems 1 al 7 (Rango: **7 a 35 puntos**). Refleja la ansiedad cognitiva previa.
- **Subescala Incertidumbre Inhibitoria (II):** Suma de los ítems 8 al 12 (Rango: **5 a 25 puntos**). Refleja la inhibición del comportamiento.
- **Puntuación Total IUS-12:** Suma aritmética de los 12 ítems (Rango total: **12 a 60 puntos**). No contiene reactivos invertidos.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Estratificación	Rango Total	Perfil Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
Tolerancia Alta	12 a 27	Tolerancia flexible a la duda	Afrontamiento adaptativo ante imprevistos. No requiere abordaje específico de la incertidumbre.
Moderada	28 a 37	Inseguridad y búsqueda de control	Tendencia a planificar en exceso y chequear información reiteradamente. Psicoeducación en aceptación de la contingencia.
Elevada	38 a 47	Intolerancia clínica (corte ≥ 38)	Patrón desadaptativo grave; disparador de preocupación incesante (TAG) o conductas de neutralización. TCC transdiagnóstica.
Extrema	48 a 60	Parálisis por duda invalidante	Colapso en la toma de decisiones, postergación crónica y conductas masivas de reaseguro interpersonal. Abordaje intensivo.

SIGNIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DEL PUNTO DE CORTE ≥ 38 :

En muestras hispanas, un puntaje global en el **IUS-12 ≥ 38** discrimina con un 84% de sensibilidad a los pacientes que cumplen criterios diagnósticos de Trastorno de Ansiedad Generalizada (DSM-5). En presencia de un factor de **Incertidumbre Inhibitoria > 18 puntos**, debe explorarse activamente el bloqueo en áreas de trabajo, estudios o vida afectiva.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA FOCALIZADA EN LA INCERTIDUMBRE

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL MODELO COGNITIVO TRANSDIAGNÓSTICO:

- **Paso 1 (Psicoeducación):** Desmontar la falacia de que "la preocupación previene catástrofes" o "prepararse al 100% elimina el riesgo". Diferenciar entre problemas solubles actuales y dudas futuras sin respuesta unívoca.
- **Paso 2 (Si predomina Incertidumbre Prospectiva):** Aplicar reestructuración cognitiva sobre creencias acerca de la preocupación y experimentos conductuales de "no-búsqueda" de información redundante en internet.
- **Paso 3 (Si predomina Incertidumbre Inhibitoria):** Exposiciones conductuales graduadas a la incertidumbre (ej. enviar mensajes sin releerlos 10 veces, ir a restaurantes sin mirar la carta previa, tomar decisiones menores en menos de 2 minutos). Reevaluación a las 8 semanas; mejoría clínica relevante si el descenso es ≥ 8 puntos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Paciente: Mujer de 33 años, investigadora postdoctoral, acude a consulta por fatiga mental, contracturas cervicales crónicas e insomnio de conciliación. Informa que pasa entre 4 y 6 horas diarias repasando mentalmente hipotéticos fallos en sus proyectos o en la salud de sus padres.

Evaluación Cuantitativa Inicial: IUS-12 = **49 puntos** (Nivel Extremo; percentil 96 clínico).

• **Incertidumbre Prospectiva:** **31 / 35 puntos** (ítem 1 = 5, ítem 2 = 5, ítem 3 = 4, ítem 7 = 5). Hipervigilancia masiva.

• **Incertidumbre Inhibitoria:** **18 / 25 puntos** (ítem 8 = 4, ítem 11 = 4, ítem 12 = 5). Procrastinación severa al enviar manuscritos.

Formulación Clínica: La paciente presenta intolerancia nuclear a la incertidumbre que actúa como motor de un Trastorno de Ansiedad Generalizada. Emplea la rumiación como una pseudoprotección mágica frente a imprevistos y chequea compulsivamente su trabajo.

Intervención y Resultados: Se aplicó el protocolo de TCC de Dugas para TAG enfocado en exposición a la incertidumbre y supresión de reaseguro. A la sesión 12, el IUS-12 descendió a **26 puntos** (Pros.: 16, Inhib.: 10), reduciendo la preocupación a niveles normales y recuperando la regularidad del descanso nocturno.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SOLAPAMIENTO CON TOC Y FOBIA DE ENFERMEDAD

En pacientes con IUS-12 > 45 y elevación extrema de la subescala prospectiva, descartar la existencia de compulsiones encubiertas de chequeo o ritos de neutralización típicos del Trastorno Obsesivo-Compulsivo y del Trastorno de Ansiedad por Enfermedad (SHAI).

DIFERENCIACIÓN FRENTE A PERFECCIONISMO CLÍNICO

La incertidumbre inhibitoria alta a menudo se camufla como "perfeccionismo meticuloso". Explorar si la lentitud responde a estándares de excelencia elevados (FMPS) o al pánico a tomar una decisión sin garantía absoluta de certeza (IUS-12).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Carleton, R. N., Norton, M. A., & Asmundson, G. J. (2007). Fearing the unknown: A short version of the Intolerance of Uncertainty Scale. *Journal of Anxiety Disorders*, 21(1), 105–117.
2. González-Rodríguez, M., et al. (2018). Propiedades psicométricas de la Escala de Intolerancia hacia la Incertidumbre (IUS-12) en población española. *Ansiedad y Estrés*, 24(2), 67–74.
3. Dugas, M. J., Gagnon, F., Ladouceur, R., & Freeston, M. H. (1998). Generalized anxiety disorder: a preliminary test of a conceptual model. *Behaviour Research and Therapy*, 36(2), 215–226.
4. Flores-Kanter, P. E., et al. (2020). Psychometric evaluation of the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS-12) in Latin America: Factor structure, measurement invariance and validity. *PLoS ONE*, 15(11), e0242229.